Proceso de atención y Ruta del paciente

Esta ruta describe en detalle los diferentes pasos que debe recorrer un paciente y sus familiares desde que se considera que su condición le hace poder ser evaluado para entrar en el Programa de Cuidados Avanzados hasta el alta del paciente en dicha atención.

Debe desarrollarse un descriptivo de esta ruta (texto), y además realizar un flujograma, que permita ver de forma visual, esta ruta y los diferentes componentes que hacen parte de ella.

En cada uno de los pasos del descriptivo se identifica: las personas implicadas, los tiempos de respuesta, los procesos más importantes a realizar, los flujos y vías de información, los documentos o registros que se generan, etc…

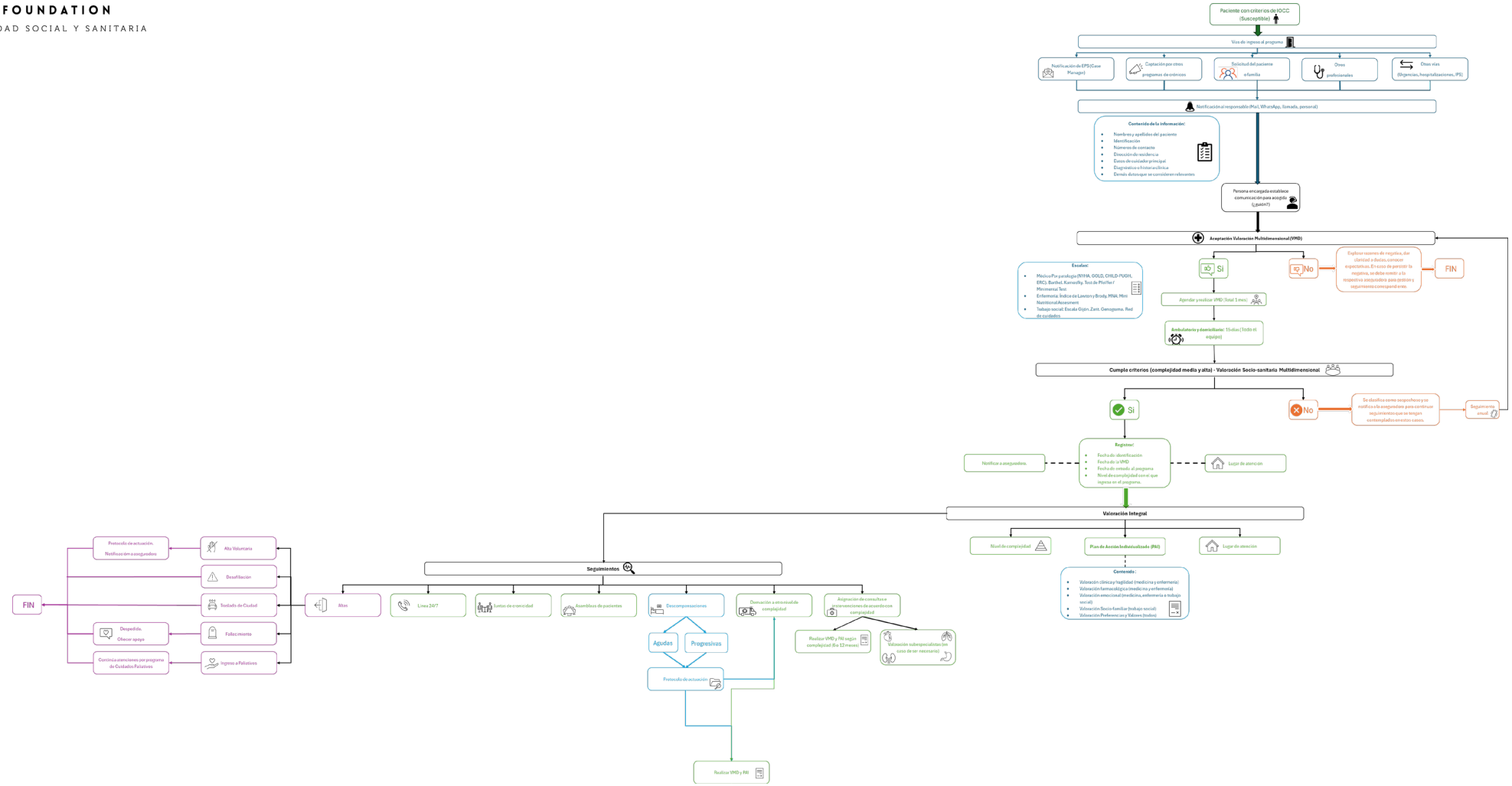
Para el diseño de la ruta habría que responder a las siguientes preguntas:

- Vías de identificación de pacientes.
- Canales de comunicación entre aseguradora y prestador para compartir datos de usuarios identificados y retorno de información sobre el estado del afiliado, cambios y ajustes requeridos.
- Datos mínimos requeridos: nombre del paciente, identificación, edad, datos de contacto, diagnóstico principal y diagnósticos asociados, datos de cuidador o de familiar responsable y demás que se consideren de importancia para la gestión.
- Profesional o persona encargada en el prestador de recibir la información enviada por el asegurador y la gestión que esta persona debe realizar.
- Contacto con el paciente: Establecer quién, cómo y cuándo se realizará.
- Agendamiento de VMD (tener en cuenta los tiempos).
- Establecer complejidad y determinar estados del paciente. Además, paso a seguir de acuerdo con la complejidad establecida en la VMD.
- Programar VI y realización de PAI. Tener en cuenta tiempos.
- Establecer frecuencias de seguimiento de acuerdo a complejidad y nivel de atención.
- Cuáles van a ser los canales de comunicación entre los profesionales de los diversos ámbitos asistenciales.
- Cómo dar respuesta a situaciones de descompensación aguda y progresiva.
- Cómo se articulará la atención 24h/7d
- Cómo se garantizará una adecuada atención en las transiciones – Paso a Cuidados Paliativos (determinar quién, cómo y cuándo se hará).
- Cómo se articula la red sanitaria y social.
- Consignar información en historia clínica.
- Asistencia a Juntas de Cronicidad, asamblea de pacientes y demás que la institución considere necesarias implementar.

- Tener siempre en cuenta las posibles vías de alta con su guía de actuación.
- Se deben nombrar todos los pasos de la atención, tiempos y responsables.

Todo esto debe ir ajustado según la realidad de cada prestador.

A continuación del proceso descrito en texto, dibujar el flujograma de la ruta esquematizando visualmente los pasos. Se comparte un ejemplo.


Paciente con criterios de ICCC (Susceptible)
Vías de ingreso al programa
Notificación de EPS (Case Manager)
Captación por otros programas de crónicos
Solicitud del paciente o familia
Otros profesionales
Otras vías (Urgencias, hospitalizaciones, IPS)
Notificación al responsable (Mail, WhatsApp, llamada, personal)
Contenido de la información:
Nombres y apellidos del paciente
Identificación
Números de contacto
Dirección de residencia
Datos de cuidador principal
Diagnóstico o historia clínica
Demás datos que se consideren relevantes
Persona encargada establece comunicación para acogida (¿paciente?)
Aceptación Valoración Multidimensional (VMD)
Escalas:
Médico: Pur paralogía (NYHA, GOLD, CHILD-PUGH, ERC), Barthel, Karnofky, Test de Pfeiffer / Minimental Test
Enfermería: Índice de Lawton y Brody, MNA: Mini Nutritional Assessment
Trabajo social: Escala Gijón, Zarit, Genograma, Red de cuidados
Si
No
Explorar razones de negativa, dar claridad a dudas, conocer expectativas. En caso de persistir la negativa, se debe remitir a la respectiva secretaría para gestión y seguimiento correspondiente.
FIN
Agendar y realizar VMD (total 1 mes)
Ambulatoria y domiciliaria: 15 días (Todo el equipo)
Cumple criterios (complejidad media y alta) - Valoración Socio-sanitaria Multidimensional
Si
No
Se detallice como sospechoso y se notifica a la aseguradora para continuar seguimientos que se tengan contemplados en estos casos.
Seguimiento enud
Registrar:
Fecha de identificación
Fecha de la VMD
Fecha de ostado al programa
Nivel de complejidad con el que ingresa en el programa.
Notificar a aseguradora.
Lugar de atención
Valoración Integral
Nivel de complejidad
Plan de Acción Individualizado (PAI)
Lugar de atención
Contenido:
Valoración clínica y fragilidad (medicina y enfermería)
Valoración farmacológica (medicina y enfermería)
Valoración emocional (medicina, enfermería o trabajo social)
Valoración Socio-familiar (trabajo social)
Valoración Preferencias y Valores (todos)
Seguimientos
Altas
Línea 24/7
Juntas de cronicidad
Asambleas de pacientes
Descompresiones
Derivación a otro nivel de complejidad
Asignación de consultas e intervenciones de acuerdo con complejidad
Realizar VMD y PAI según complejidad (6 o 12 meses)
Valoración subespecialistas (en caso de ser necesario)
Agudas
Progresivas
Protocolo de actuación
Realizar VMD y PAI
Protocolo de actuación. Notificación a aseguradora
Alta Voluntaria
Desafiliación
Traslado de Ciudad
Fallecimiento
Ingreso a Paliativos
Despedida. Ofrecer apoyo
Continúa atenciones por programa de Cuidados Paliativos
FIN